

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	PENATALAKSANAAN SYOK ANAFILAKTIK		
	No. Dokumen 1051/RSPHS/I-SPO/DIR/XII/2025	No. Revisi 00	Halaman 1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 01 Desember 2025	Ditetapkan Oleh : Direktur Rumah Sakit Prima Husada  Ns. Heni Indra Wulandari, S. Kep, M. Kep
Pengertian	Syok anafilaktik adalah reaksi hipersensitivitas sistemik yang berat, terjadi cepat dan mengancam jiwa, ditandai dengan gangguan jalan napas, pernapasan, sirkulasi, dan/atau penurunan kesadaran akibat pelepasan mediator alergi.	
Tujuan	Sebagai pedoman bagi tenaga kesehatan dalam melakukan penatalaksanaan syok anafilaktik secara cepat, tepat, dan aman untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas.	
Kebijakan	Pedoman Pengelolaan Vaksin di Fasilitas Pelayanan Kesehatan No 614.47	
Prosedur	A. Identifikasi dan Tindakan Awal 1. Hentikan paparan alergen segera 2. Aktifkan respon gawat darurat / Code Blue bila perlu 3. Posisikan pasien supine dengan tungkai diangkat (kecuali sesak berat) 4. Pastikan jalan napas (Airway), pernapasan (Breathing), dan sirkulasi (Circulation) B. Terapi Farmakologis Utama 1. Adrenalin (Epinefrin) – Lini Pertama a) Dosis dewasa: 0,3–0,5 mg IM (1:1000) di paha anterolateral b) Anak: 0,01 mg/kgBB IM (maks. 0,3 mg) c) Ulangi tiap 5–15 menit bila perlu 2. Oksigen Aliran tinggi 6–10 L/menit melalui masker 3. Cairan Intravena a) NaCl 0,9% atau Ringer Laktat bolus cepat b) Dewasa: 1–2 liter c) Anak: 20 ml/kgBB 4. Antihistamin (terapi tambahan) Diphenhydramine 25–50 mg IV/IM 5. Kortikosteroid Hydrocortisone 100–200 mg IV 6. Bronkodilator (bila bronkopasme) Salbutamol nebulisasi	



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PENATALAKSANAAN SYOK ANAFILAKTIK

No. Dokumen
1051/RSPHS/I-SPO/DIR/XII/2025

**No.
Revisi**
00

Halaman
2/2

C. Monitoring dan Tindak Lanjut

1. Monitor tanda vital setiap 5–15 menit
2. Observasi minimal 24 jam (risiko reaksi bifasik)
3. Dokumentasi lengkap di rekam medis
4. Edukasi pasien dan keluarga terkait alergi
5. Pencatatan reaksi obat / alergen di SIMRS.

D. Kriteria Rujukan / Ekalisasi

1. Tidak respon terhadap adrenalin IM berulang
2. Perburukan jalan napas
3. Hipotensi persisten

E. Dokumentasi

Catatan pemberian obat emergensi

Unit Terkait

1. Instalasi Gawat Darurat
2. Instalasi Kamar Operasi
3. Instalasi Rawat Jalan
4. Instalasi Rawat Inap
5. Maternitas
6. Intensive Care Unit
7. Neonatal Intensive Care Unit